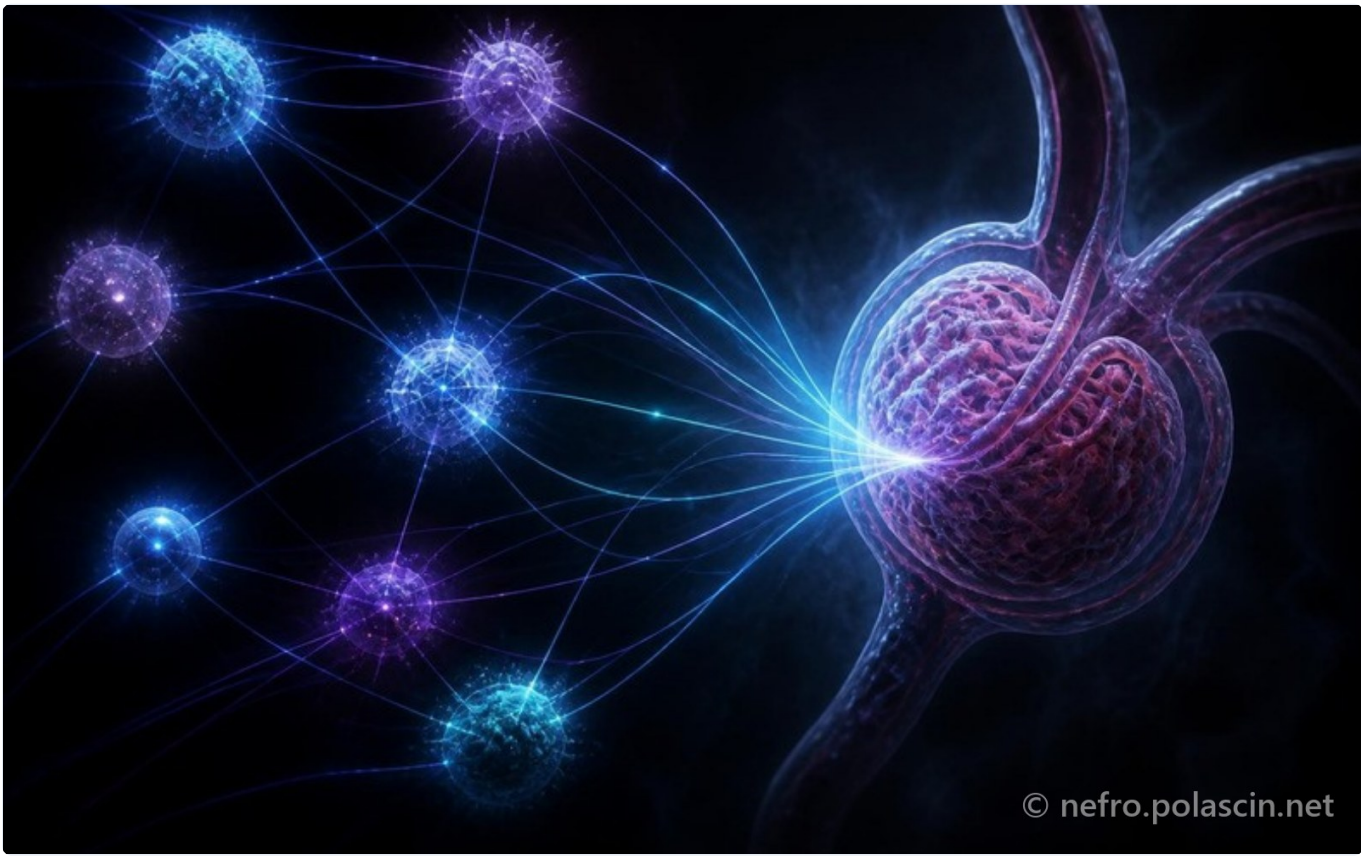
Porovnávacia účinnosť liečby IgA nefropatie: sieťová metaanalýza

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 08.05.2026



Ilustračná scéna. Sieťová analýza porovná aj to, čo sa priamo proti sebe nikdy netestovalo.

V apríli 2026 bola publikovaná bayesovská sieťová metaanalýza, ktorá porovnala konvenčné imunosupresíva s novšími cielenými liekmi pri liečbe IgA nefropatie (IgAN) u dospelých. Vedci prehľadali databázy PubMed, Cochrane Library, Web of Science, Scopus a Embase od začiatku do marca 2025 a do analýzy zaradili 17 randomizovaných klinických štúdií.

Aké lieky sa porovnávali?

- Metylprednizolón
- Mykofenolát mofetil
- Takrolimus
- Nefecon (budezonid s cieleným uvoľňovaním)
- Iptakopan
- Sibeprenlimab

Všetky lieky sa porovnávali s placebom alebo štandardnou podpornou liečbou. Sledovali sa renálne funkcie (eGFR slope), proteinúria (pomer bielkovín a kreatinínu v moči – UPCR) a závažné nežiaduce udalosti.

Hlavné výsledky

Funkcia obličiek (eGFR slope) – Nefecon dosiahol najpriaznivejší bodový odhad a najvyššie SUCRA hodnotenie, čo naznačuje potenciálne priaznivý signál. 95 % intervaly dôveryhodnosti však zahŕňali nulový efekt, takže nemožno hovoriť o preukázanej nadradenosti.

Proteinúria – Metylprednizolón viedol k najväčšiemu zníženiu pomeru bielkovín a kreatinínu v moči (UPCR) v porovnaní s placebom. Aj iptakopan a sibeprenlimab boli spojené so znížením proteinúrie. Viaceré liečby teda

vykázali prínos, no ich vzájomné postavenie zostáva neisté.

Bezpečnosť – Porovnania závažných nežiaducich udalostí boli prevažne nepresvedčivé, keďže údajov bolo málo a intervaly neistoty široké. Iptakopan vykázal numericky nižší výskyt závažných nežiaducich udalostí, ale aj tento signál zostáva neistý.

Podskupiny – Analýzy nepreukázali, že by bol účinok liečby výrazne ovplyvnený vstupnou funkciou obličiek (eGFR pod alebo nad 60 ml/min/1,73 m²).

Čo to znamená v praxi?

Autori zdôrazňujú, že ide o **exploratívne zistenia**, nie o dôkaz nadradenosti niektorej liečby. Sieť porovnaní bola riedka, režimy liečby heterogénne a sledovanie krátke. Na jednoznačné závery sú potrebné väčšie a dlhšie štúdie s priamym porovnávaním liekov a tvrdými renálnymi ukazovateľmi (napr. zlyhanie obličiek).

Napriek obmedzeniam môžu tieto signály pomôcť pri **individualizovanom rozhodovaní** o liečbe u konkrétnych pacientov s IgA nefropatiou.

Zdroj: ReachMD, zverejnené 24. apríla 2026

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=porovnavacia-ucinnost-liecby-iga-nefropatie-sietova-metaanalaza · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.